# 8.8.1. 감염성질환 관리

| 제 정 일 | 2006.07. | 최 종 개 정 일 | 2025.03.25. | 최 종 검 토 일 | 2025.03.25. |
|---|---|---|---|---|---|
| 담 당 부 서 | 감염관리실 | | | | |
| 유 관 부 서 | | | | | |

| 관 련 기 준 | 4주기 의료기관인증기준: 8.8 감염성질환 및 면역저하 환자관리<br>JCI Standard 7th Edition: PCI.1~15 |
|---|---|

제1조 (목적)

1. 감염성질환자나 감염이 의심되는 환자로부터 다른 환자나 직원이 감염되거나 미생물이 전파되는 것을 예방하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 감염성질환: 타인에게 전파가 가능한 법정감염병(법정감염병 목록에 등록된 질병) 또는 감염질환

제3조 (절차)

1. 전파경로에 따라 격리가 필요한 감염병 대상
   1) 공기주의
      (1) 감염원이 공기를 통하여 전염되는 것으로 5㎛보다 작은 크기의 물질에 의한 감염을 예방하기 위하여 적용한다.
      (2) 해당질환: 홍역(measles), 수두(chicken pox), 파종성 대상포진(disseminated herpes zoster), 활동성 폐결핵(active pulmonary tuberculosis)
   2) 비말주의
      (1) 비말전파는 감염되었거나 보균상태의 환자가 기침, 재채기, 말할 때 또는 기관지경이나 흡인과 같은 치료과정을 수행할 때 생성되는 5㎛보다 큰 비말에 의해 발생한다. 생성된 비말은 공기 중에 부유할 수 없으며 근거리(약 1m) 내에서 전파된다. 표준주의에 비말주의를 함께 적용한다.
      (2) 해당질환
         ① b형 헤모필루스 인플루엔자에 의한 수막염, 후두개염, 신생아와 유아의 폐렴
         ② 수막구균에 의한 수막염, 폐렴, 패혈증
         ③ A군 사슬알균에 의한 인두염, 폐렴, 성홍열, 중증 침습적 질환
         ④ 기타 비말에 의해 전파되는 세균성 호흡기계 감염: 인두디프테리아, 마이코플라즈마폐렴, 백일해, 폐페스트
         ⑤ 기타 비말에 의해 전파되는 바이러스성 감염: 아데노바이러스, 리노바이러스, 인플루엔자, 유행성이하선염, 파보바이러스 B19, 풍진, 코로나바이러스 감염증-19
   3) 접촉주의
      (1) 의료관련감염에서 가장 중요하고, 빈번하게 적용되는 방법으로 환자의 치료과정에서

의료인의 손이나 피부의 직접 접촉으로 미생물이 전파되는 것을 예방하기 위하여 표준주의에 접촉주의를 함께 적용한다.

(2) 해당질환

① 소화기계, 호흡기계, 피부 또는 창상의 감염이나 다제내성균이 집락된 경우: MRSA, VRSA/VISA, VRE, CRE/CPE, PDRAB 등

② 감염률이 낮지만, 오랫동안 환경에서 생존하는 장 감염

a. *Clostridioides difficile*

b. 기저귀를 사용하거나 실금환자의 경우: 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 장출혈성대장균감염증, 세균성이질, A형간염, E형간염, 로타바이러스 감염, 노로바이러스 감염

③ 신생아와 유아의 호흡기세포융합바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 엔테로바이러스 감염

④ 높은 전염력을 가진 또는 피부를 통해 전염될 수 있는 피부감염: 피부디프테리아, 신생아 또는 점막하의 단순포진바이러스, 농가진, 농양, 봉와직염, 또는 욕창, 이, 기생충, 옴, 신생아와 유아의 포도구균, 전신성 혹은 면역저하환자의 대상포진

⑤ 바이러스 결막염

⑥ 칸디다속 진균 중 하나로 오염된 표면이나 사람과의 접촉을 통해 전파: *Candida auris*

2. 유행성 감염병 위기 상황 시 외래환자 감염성 질환 관리

1) 유행성 감염병에 대한 최신 정보 공유 절차

(1) 국내 및 국외의 감염성질환의 대량발생에 대한 동향 파악 및 정부와의 긴밀한 정보교류를 위하여 질병관리청(http://www.kdca.go.kr)의 상황을 최소 주 단위로 파악하고 필요 시 원내 공지한다.

(2) 국가위기경보수준 주의 단계 이상에 해당되는 경우 이메일, 그룹웨어 게시판을 이용하여 원내 공지한다.

2) 의심환자 선별: 역학적 연관성(해외방문력, 노출력 등) 및 감염 의심 증상을 확인한다.

3) 감염전파 예방 수칙 준수

(1) 원내 지침에 따라 손위생을 시행한다.

(2) 감염전파경로에 따른 적절한 개인보호구를 착용한다.

4) 환자 이송방법

(1) 환자 이동 시 직원과 환자는 적절한 개인보호구를 착용한다.

(2) 이동동선은 최대한 짧게 구성하며 필요 시 동선통제를 한다.

(3) 도착 부서에 전파경로, 격리 등 필요한 환자 정보를 공유한다.

5) 노출관리

(1) 환경관리: 의심환자와 확진환자 진료공간의 환경소독, 의료폐기물 및 세탁물 관리지침을 엄격히 준수한다.

(2) 환자 담당 의료진 감염예방 및 관리

① 환자의 감염이 의심되거나 개인보호구가 필요한 상황에서 적극적인 개인보호구를 착용한다.

② 노출자 관리가 필요한 감염병에 노출된 경우, 지침에 따라 관리한다. ([감염관리지침] V. 직원감염관리_3. 감염성 질환 노출 시 관리 참조)

3. 응급진료센터 내원 환자의 감염성질환 관리 절차

1) 정보안내

(1) 대상: 환자 및 보호자

(2) 내용: 감염성질환에 대한 정보와 진료절차 및 주의사항(손위생, 호흡기 예절 등)

(3) 방법: 홈페이지 또는 의료기관(응급진료센터) 입구에 게시하거나 안내

2) 응급진료센터 진료 전 환자분류소에서의 관리

(1) 환자 진료: Triage를 담당하는 의료인은 환자의 증상 및 상태를 고려하여 필요한 경우, 적절한 선제격리를 진행한다.

(2) 환자 담당 의료진 감염예방 및 관리: Triage를 담당하는 의료인은 매 환자 초기 사정 시 마스크, 장갑 등의 적절한 개인보호구를 사용하며, 이러한 개인보호구는 언제든지 사용할 수 있도록 비치하여 놓는다.

(3) 보호자 명부 작성: 보호자(대리인) 1인 상주를 원칙으로 하며, 방문객 명부(성명, 환자와의 관계, 연락처)를 작성하여 1년간 기록을 보관한다.

3) 감염전파 예방 수칙 준수: 모든 환자에 대하여 손위생 및 표준주의를 준수하며, 의심되는 감염전파 경로에 따른 개인보호구를 착용한다. 환자가 기침이나 재채기를 하거나 호흡기 감염의 증상/징후가 있는 경우 마스크를 제공한다.

4) 환자 이송방법

(1) 환자 이동 시 직원과 환자는 적절한 개인보호구를 착용한다.

(2) 이동동선은 최대한 짧게 구성하며 필요 시 동선통제를 한다.

(3) 도착 부서에 전파경로, 격리 등 필요한 환자 정보를 공유한다.

5) 노출 관리

(1) 구역 방역: 의삼환자와 확진환자 진료공간의 환경소독, 의료폐기물 및 세탁물 관리지침을 엄격히 준수한다.

(2) 환자 담당 의료진 감염예방 및 관리

① 환자의 감염이 의심되거나 개인보호구가 필요한 상황에서 적극적인 개인보호구를 착용한다.

② 노출자관리가 필요한 감염병에 노출된 경우, 지침에 따라 관리한다. ([감염관리지침] V. 직원감염관리_3. 감염성 질환 노출 시 관리 참조)

6) 유행성 감염병에 대한 최신 정보 공유 절차

(1) 국내 및 국외의 감염성질환의 대량발생에 대한 동향 파악 및 정부와의 긴밀한 정보교류를 위하여 질병관리청(http://www.kdca.go.kr)의 상황을 최소 주 단위로 파악하고 필요 시 원내 공지한다.

(2) 국가위기경보수준 주의 단계 이상에 해당되는 경우 이메일, 그룹웨어 게시판을 이용하여 원내 공지한다.

4. 전파경로에 따른 격리 절차

1) 격리병실 배치 및 격리병실 제공이 불가능한 경우 대응

(1) 공기매개주의: 음압(negative pressure)격리병실을 사용하며 시간당 최소한 6회 이상 공기를 교환해야 한다. 음압격리실이 없는 경우는 격리가 가능한 타병원으로 전원하고 부득이하게 본원 입원이 필요한 경우는 1인실에 이동형 High Efficiency Particulate Air(HEPA) 필터를 설치하여 일시적으로 사용할 수 있다.

(2) 비말주의: 가능한 1인실을 사용하거나 동일한 병원균에 감염되었거나 보균한 환자끼리 한 방을 사용하는 것(코호트)이 적절하다. 부득이한 경우 1m 이상의 간격을 유지하고, 접촉의 기회를 줄이기 위해 가능한 침대 사이에 물리적 차단막(커튼)을 설치한다.

(3) 접촉주의: 감염 전파 위험이 높은 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 장출혈성대장균감염증, 세균성이질, A형 간염, CPE, PDRAB, VRSA/VISA 환자는 1인실이나 코호트 격리를 필요로 한다. 질병의 종류나 환자상태에 따라 반드시 1인실이나 코호트 격리가 필요하지는 않으므로 상황을 고려하여 병실을 결정하고 VRE, CRE 환자는 일반병실 내 접촉주의를 적용한다.

2) 병실 준비물품

(1) 격리방법에 따른 주의표식 부착

(2) 격리물품 및 의료장비 준비

(3) 공기매개 감염질환 의심/확진 환자 격리 시, 격리실에 입실하기 전 음압상태를 확인(Smoke test, 차압계)하고, 격리기간 동안은 매일 음압상태를 확인한다.

3) 환경 관리

(1) 병실 청소 및 소독: 환자 주변 환경과 환자가 자주 접촉하는 표면은 다른 환경 표면보다 더 자주 청소하고 소독하며, 환경소독 시에는 공인된 소독제를 사용한다.

(2) 폐기물처리: 세브란스병원 내규 [11.3.2. 의료폐기물 관리]에 따라 관리한다.

(3) 식기관리: 격리환자에게 제공한 식기의 관리는 세브란스병원 내규 [8.7.1. 급식서비스 관리] 및 [감염관리지침] VII. 부서별 감염관리_13. 조리장에 따른다.

(4) 세탁물관리: 격리환자에게 제공한 세탁물의 관리는 세브란스병원 내규 [8.5.2. 세탁물 관리] 및 [감염관리지침] IX. 환경관리_3. 병원세탁물에 따른다.

4) 환자 및 보호자 대상으로 격리 관련 준수사항 교육

(1) 의료진은 환자 및 대리인에게 격리 시작 시 격리목적, 격리실 생활 안내 등을 교육하고, 격리해제 시 해당 내용을 설명한다.

5) 환자에게 사용한 의료기기 또는 물품 관리

(1) 사용지침에 따라 1회 사용 물품과 재사용하는 물품을 관리하고 폐기한다.

6) 직원 간 정보공유 방법

(1) u-Severance 'I' precaution 확인

(2) 격리방법에 따른 주의표식

7) 감염병 전파경로에 따른 보호구 종류, 착용 및 탈의(제거) 방법

(1) [감염관리지침] III. 표준주의_2.개인보호구 및 IV.감염성질환 관리_4.격리의 종류와 방법에 따른다.

8) 환자 이송방법

(1) 환자의 이동을 최소화하며, 불가피하게 이송을 하게 되는 경우 이송도착 부서와 격리정보를 공유한다.

(2) 공기주의 환자 이동 시 환자는 외과용 마스크를 착용하고 호흡기계 위생/호흡기 예절을 준수하도록 교육한다. 수두, 홍역이나 피부결핵 등으로 배액성 피부병변이 있는 환자는 피부병변이 노출되지 않도록 깨끗한 직물로 덮어준다.

(3) 비말주의 환자 이동 시 환자는 외과용 마스크를 착용시키고 호흡기계 위생/호흡기 예절을 준수하도록 교육한다.

(4) 접촉주의 환자 이동 시 환자에게 덧가운을 입히거나 깨끗한 시트로 환자를 감싸 환경을 오염시키지 않도록 주의한다.

9) 관련 직원 교육

(1) 전파경로에 따른 격리원칙, 보호구 종류 및 보호구 착탈의 순서 등에 대한 교육을 받는다.

10) 방문객 관리

(1) 전파경로에 따른 격리지침을 준수한다.

(2) 자세한 사항은 세브란스병원 내규 [11.4.1. 보안관리] 및 [감염관리지침] IV. 환경관리_4. 방문객 관리에 따른다.

5. 음압 격리 병실 설치 및 관리

1) 설치기준

(1) 의료법 시행규칙 [별표 4 의료기관의 시설규격]을 따른다.

(2) 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 4의2 음압병실 설치·운영 기준]에 따른다.

2) 음압유지를 위한 관리

(1) 시설관리팀: 매일 아침 음압상황을 모니터링하고 그 결과를 보관한다. 문제 발생 시에는 즉시 점검한다.

(2) 음압시설 부서: Smoke test 또는 차압계 -2.5Pa 이하로 확인한다.

(3) 공기매개 감염성질환 환자가 입원하는 음압병실이 있는 부서는 다음과 같이 시행한다.

① 격리실 사용을 시작할 때 점검

② 격리실을 사용하고 있는 경우에는 매일 점검

③ 격리실을 사용하지 않는 경우에는 1회/월 점검

(4) 문제 발생 시 관리 방법

① 방문과 창문의 밀폐상태를 확인하고 30분 후에 다시 점검한다.

② 문제 상황에 따라 시설관리팀 등 관련부서에 연락하여 해결한다.

제4조 (부록)

1. 감염관리지침

제5조 (참고)

1. 의료법 시행규칙
2. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률
3. CDC. Guideline for Isolation Precaution: Preventing transmission of Infection Agents in Healthcare settings. 2007.

# 내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)